

1 乳がんの薬薬連携 — 内分泌療法・CDK4/6・抗HER2

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① サブタイプ・閉経状況とレジメンの整合性の監査	サブタイプ・治療目的 (術後・転移)	① 内分泌療法・CDK4/6阻害薬の服用日・休業日・残薬の管理
② アントラサイクリン累積量・心エコー予定の管理	好中球数・肝機能 (CDK4/6阻害薬)	② 他院の抗うつ薬・抗菌薬・市販薬・サブリの相互作用確認
③ 化学療法の制吐薬・G-CSFの設定、導入時の説明	心機能 (LVEF)(抗HER2薬・アントラサイクリン)	③ 関節痛・ほてりなど継続の妨げになる症状の聴取と対処
④ T-DXdのILD、CDK4/6阻害薬の血液検査への対応	関節痛・自己中断 (内分泌療法)	④ 電話フォローで下痢(アベマシクリブ)・発熱を確認
⑤ 術後内分泌療法の予定期間(5年・10年)を薬局へ伝達		⑤ 骨密度検査・歯科受診の状況を確認し、病院へ情報提供

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

AC/EC→タキサン 点滴・注射	ドキシソルピシン(エピルピシン)+シクロホスファミド → バクリタキセル毎週またはドセタキセル 2~3週毎	✓ 高度催吐性の制吐薬 ✓ 脱毛 ✓ アントラサイクリンの累積投与量
タモキシフェン 経口	20mg 1日1回 連日内服(5~10年) 連日	✓ CYP2D6阻害薬(パロキセチン等) ✓ ほてり ✓ 不正性器出血・下肢の腫れ
アロマターゼ阻害薬 経口	アナストロゾール/レトロゾール/エキセメスタン 1日1回 連日	✓ 関節痛・こわばり ✓ 骨密度検査・骨粗鬆症治療薬
パルボシクリブ 経口	125mg 1日1回 21日服用・7日休業(内分泌療法と併用) 4週毎	✓ 好中球減少(服用前の血液検査) ✓ 服用日と休業日 ✓ CYP3A阻害薬
アベマシクリブ 経口	150mg 1日2回 連日内服(内分泌療法と併用) 連日	✓ 開始早期の下痢(止瀉薬を携帯) ✓ 肝機能 ✓ 静脈血栓塞栓症
T-DXd 点滴・注射	点滴(HER2陽性・HER2低発現) 3週毎	✓ 咳・息切れ・発熱(ILD) ✓ 悪心・嘔吐への制吐薬

● 経口 ● 点滴・注射 ● 点滴+経口 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休業日と自宅での副作用を確認

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書 併用注意	タモキシフェン CYP2D6阻害(活性化↓)	処方薬 パロキセチン等のSSRI	活性代謝物↓ → 効果減弱のおそれ	他院の抗うつ薬を確認し、代替を処方医と相談
注意 添付文書 併用注意	タモキシフェン 抗凝血作用の増強	処方薬 ワルファリン	INR↑ → 出血	INR測定の前日を確認
注意 添付文書 併用注意	パルボシクリブ・アベマシクリブ CYP3A4阻害	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系抗真菌薬	血中濃度↑ → 好中球減少・下痢↑	他院の抗菌薬・抗真菌薬の処方を確認
注意 添付文書 併用注意	CDK4/6阻害薬 CYP3A4阻害・誘導	サプリ・食品 グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウ	副作用↑・効果↓	食品・サプリの摂取を聴取
注意 添付文書 併用注意	アロマターゼ阻害薬 作用の拮抗	処方薬 エストロゲン製剤(ホルモン補充療法等)	内分泌療法の効果減弱	婦人科など他院の処方を確認
確認 添付文書 重要な基本的注意	デノスマブ・ソレドロン酸 顎骨壊死のリスク	処置・検査 抜歯などの歯科治療	顎骨壊死	歯科受診時に使用を伝えるよう指導

4 服薬指導タイムライン — 乳がんの治療に合わせて

① 治療開始前	② CDK4/6開始期	③ パルボシクリブ服用中	④ 長期服用中
“この治療は年単位で続きます。飲み忘れを防ぐため、お薬カレンダーや服用時間を一緒に決めましょう”	“下痢が出たら、お渡しした下痢止めをすぐに飲み、水分を多めにとってください”	“3週間飲んで1週間お休みします。お休みの週も体温を測り、熱が出たら連絡してください”	“関節のこわばりやほてりは、つらければ対処法があります。我慢せずに教えてください”
✓ 薬局で確認 お薬手帳でサブタイプ・治療目的、併用薬(CYP2D6・CYP3A4関連、市販薬)	✓ 薬局で確認 電話フォローで下痢の回数と止瀉薬の使い方を確認	✓ 薬局で確認 服用日と休業日、処方箋の好中球数	✓ 薬局で確認 内分泌療法の継続状況・残薬、関節痛・ほてりの程度
△ ここに注意 パロキセチン等はタモキシフェンの効果を弱めるおそれ	△ ここに注意 止瀉薬で24時間以内に改善しない時は連絡	△ ここに注意 発熱時は休業中の週でも病院へ連絡	△ ここに注意 息切れ・むくみ・咳が続く時は早めに受診